

FICHA TÉCNICA PSICOMÉTRICA

ESCALAS BIS/BAS (CARVER & WHITE, 1994)

Eje II: Procesos Psicológicos • Sistemas de Inhibición y Activación Conductual (Sensibilidad al Refuerzo)

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL DEL INSTRUMENTO

Nombre Oficial (Español)	Escalas de Inhibición y Activación Conductual (BIS/BAS: 24 ítems).
Nombre Original (Inglés)	<i>Behavioral Inhibition System and Behavioral Activation System Scales (BIS/BAS)</i>
Autores Originales	Drs. Charles S. Carver y Teri L. White (1994), University of Miami.
Adaptaciones Españolas	Sandra Torrubia, Ávila-Espada et al. (2001); Romero et al. (2003); Ferrando et al.
Eje Clínico y Constructo	Eje II: Procesos Psicológicos. Teoría de la Sensibilidad al Refuerzo de Jeffrey Gray (RST).
Tipo de Instrumento	Autoinforme de 24 reactivos (20 puntuables + 4 distractores) con escala Likert de 4 puntos (1 a 4).
Población y Rango	Adolescentes y adultos (desde 14 años). Baremos en población clínica y comunitaria.
Tiempo de Administración	4 a 6 minutos en autoadministración.
Régimen de Licencia	Acceso abierto para uso clínico, docente y de investigación bajo citación científica.

2. FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL Y TEORÍA DE LA SENSIBILIDAD AL REFUERZO (GRAY)

Las Escalas BIS/BAS fueron concebidas para evaluar las dos dimensiones neurobiológicas motivacionales primarias propuestas por la Teoría de la Sensibilidad al Refuerzo (RST) de Jeffrey A. Gray:

- Sistema de Inhibición Conductual (BIS):** Regula la sensibilidad al castigo, a la no recompensa frustrante y a la novedad aversiva. Cuando se activa, interrumpe la conducta en curso, eleva la vigilancia atencional y genera afecto negativo (ansiedad, aprensión e inhibición conductual). Sustentado por el circuito septo-hipocampal, la amígdala y el córtex prefrontal dorsolateral derecho (noradrenalina y serotonina).
- Sistema de Activación Conductual (BAS):** Regula la sensibilidad a señales de recompensa y escape activo. Moviliza la conducta de aproximación apetitiva hacia metas deseadas y genera afecto positivo (entusiasmo, júbilo y deseo). Sustentado por el sistema dopaminérgico mesolímbico (área tegmental ventral y núcleo accumbens) y la corteza prefrontal izquierda.

Carver y White operacionalizaron el BAS en tres subescalas interconectadas: **Impulso (Drive)** (búsqueda tenaz de metas), **Búsqueda de Diversión (Fun Seeking)** (impulsividad y deseo de sensaciones nuevas) y **Reactividad a la Recompensa (Reward Responsiveness)** (placer ante resultados positivos).

3. DOMINIOS EVALUADOS Y COMPOSICIÓN FACTORIAL DE ÍTEMS

Sistema / Dimensión	Ítems (24)	Sentido	Definición Operativa y Foco Clínico Evaluado
1. BIS (Inhibición / Castigo)	2 (*), 8, 13, 16, 19, 22 (*), 24	7 ítems (2 inv)	Susceptibilidad al miedo al fracaso, preocupación y dolor ante reproches.
2. BAS Impulso (Drive)	3, 9, 12, 21	Directos (4)	Tenacidad proactiva y motivación para conseguir lo que se desea.
3. BAS Búsqueda Diversión	5, 10, 15, 20	Directos (4)	Impulsividad apetitiva y necesidad de nuevas sensaciones estimulantes.
4. BAS Recompensa	4, 7, 14, 18, 23	Directos (5)	Grado de regocijo, afecto positivo y vivencia energética ante éxitos.
5. Ítems de Relleno	1, 6, 11, 17	Distractores (4)	Ítems neutros de despiste no incluidos en el cómputo de puntuaciones.

(*) Los reactivos 2 y 22 del BIS se invierten obligatoriamente antes de realizar la sumatoria.

PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS, BAREMOS Y CORRECCIÓN

4. VALIDEZ, CONFIABILIDAD Y RENDIMIENTO DIAGNÓSTICO EN ESPAÑA / LATAM

Consistencia Interna	Excelente precisión en población española (Romero et al., 2003; Ávila et al., 2001): alfa de Cronbach de 0.78 a 0.82 para la subescala BIS y 0.83 para BAS Total (BAS Impulso = 0.76; BAS Búsqueda Diversión = 0.72; BAS Recompensa = 0.74). Fiabilidad test-retest $r = 0.71$ a 8 semanas.
Estructura Factorial	El Análisis Factorial Confirmatorio corrobora la solución canónica de 4 factores oblicuos (un factor BIS y 3 factores interrelacionados para el constructo multidimensional BAS) con ajuste excelente (CFI = 0.93, TLI = 0.91, RMSEA = 0.054).
Validez Concurrente y Divergente	La escala BIS correlaciona fuertemente con Neuroticismo (NEO-PI-R, $r = 0.62$) y Ansiedad Rasgo (STAI, $r = 0.58$). La escala BAS correlaciona directamente con Extraversión ($r = 0.53$), afecto positivo (PANAS-P, $r = 0.46$) y conductas de aproximación.
Sensibilidad al Cambio y Pronóstico	El BIS predice la respuesta a fármacos ansiolíticos e inhibidores de la recaptación de serotonina; perfiles de BAS bajo predicen anhedonia refractaria en depresión resistente que responde a activación conductual.
Diferencias de Género	Las mujeres presentan puntuaciones sistemáticamente más elevadas en la escala BIS ($M = 21.2$ vs. $M = 18.8$ en varones) y en BAS Recompensa, mientras que los varones puntúan ligeramente más alto en BAS Búsqueda de Diversión.

5. REGLAS DE CORRECCIÓN Y CÁLCULO DE PUNTUACIONES

Los 24 ítems se responden de 1 (**Muy en desacuerdo**) a 4 (**Muy de acuerdo**):

- **Paso 1 (Inversión Obligatoria de Ítems 2 y 22):** En la subescala BIS, invertir los reactivos 2 y 22: Puntuación = 5 - Respuesta (1 → 4, 2 → 3, 3 → 2, 4 → 1).
- **Paso 2 (Descarte de Ítems Neutros):** No contabilizar los ítems 1, 6, 11 y 17 (ítems de relleno).
- **Paso 3 (Puntuaciones por Subescala):**
 - **BIS (7 ítems):** Suma de 2 (inv), 8, 13, 16, 19, 22 (inv), 24. Rango: **7 a 28 puntos**.
 - **BAS Impulso (Drive - 4 ítems):** Suma de 3, 9, 12, 21. Rango: **4 a 16 puntos**.
 - **BAS Búsqueda de Diversión (Fun Seeking - 4 ítems):** Suma de 5, 10, 15, 20. Rango: **4 a 16 puntos**.
 - **BAS Recompensa (Reward - 5 ítems):** Suma de 4, 7, 14, 18, 23. Rango: **5 a 20 puntos**.
 - **BAS Total (13 ítems):** Suma de las 3 facetas BAS. Rango: **13 a 52 puntos**.

6. ESTRATIFICACIÓN CLÍNICA Y BAREMOS NORMATIVOS (ESPAÑA / LATAM)

Dimensión	Puntuación	Nivel de Sensibilidad	Significación Clínica y Conductual
BIS (Castigo)	7 a 18 pts	Inhibición normal / baja	Buena tolerancia a la crítica y baja vulnerabilidad a la ansiedad.
BIS (Castigo)	19 a 22 pts	Inhibición moderada	Nivel adaptativo medio; reactividad ansiosa normal ante estresores.
BIS (Castigo)	23 a 28 pts	Hipersensibilidad al castigo (corte ≥ 23)	Vulnerabilidad severa a fobias, pánico, TAG y rumiación autocrítica.
BAS Total	13 a 31 pts	Hipoactivación motivacional	Riesgo alto de anhedonia depresiva, abulia y baja iniciativa apetitiva.
BAS Total	32 a 42 pts	Activación normativa	Orientación equilibrada hacia metas y búsqueda adaptativa de bienestar.
BAS Total	43 a 52 pts	Hiperactivación apetitiva	Impulsividad motora, búsqueda extrema de riesgo, ludopatía o bipolaridad.

PERFILES DE DESBALANCE MOTIVACIONAL CLÍNICO:

• **Perfil Ansioso-Depresivo:** BIS muy alto (> 23) y BAS bajo (< 32). Paciente paralizado por miedo al error sin reforzadores activos. • **Perfil Búsqueda de Riesgo / Adictivo:** BIS bajo (< 16) y BAS Búsqueda de Diversión muy alto (> 14). Sujeto insensible a las consecuencias aversivas pero con un craving intenso de gratificación inmediata (abuso de sustancias, impulsividad psicopática).

APLICACIÓN CLÍNICA, CASO ILUSTRATIVO Y REFERENCIAS

7. ALGORITMO DE DECISIÓN TERAPÉUTICA SEGÚN EL PERFIL MOTIVACIONAL (RST)

PROTOCOLO CLÍNICO BASADO EN EL PERFIL DE SENSIBILIDAD AL REFUERZO:

- **Caso BIS Alto / BAS Bajo (Inhibición y Anhedonia):** Priorizar **Activación Conductual (BATD)**. Establecer contratos de reforzamiento positivo contingente y tareas graduadas de baja fricción para despertar el BAS; desacelerar la hipervigilancia del BIS con reestructuración de catástrofes.
- **Caso BIS Bajo / BAS Alto (Impulsividad y Conductas de Riesgo):** Entrenamiento en control inhibitorio reflexivo (técnicas de parada, coste de respuesta), exposición con prevención de respuesta de craving y anticipación deliberada de castigos futuros.
- **Monitorización:** Una convergencia hacia el rango normativo medio (BIS 18-21, BAS 35-40) predice estabilidad anímica duradera.

8. CASO CLÍNICO ILUSTRATIVO: INTERVENCIÓN EN DEPRESIÓN CON ANHEDONIA PROFUNDA

Identificación: Mujer de 26 años, estudiante universitaria de posgrado, remitida por cuadro de Depresión Mayor persistente de 8 meses con hipersomnia, abandono académico, aislamiento social y queja de “no sentir placer con nada”.

Evaluación Inicial BIS/BAS (Línea Base): BIS = **26/28 puntos** (Hipersensibilidad al castigo severa); BAS Total = **22/52 puntos** (Hipoactivación dopaminérgica masiva). Desglose BAS: Impulso = 6/16; Búsqueda de Diversión = 6/16; Sensibilidad a la Recompensa = 10/20. BDI-II = 36 puntos.

Tratamiento Aplicado: Protocolo de Activación Conductual para la Depresión (BATD; Lejuez et al.) de 12 semanas, acompañado de psicoeducación sobre el apagado del BAS. Se programaron conductas reforzantes guiadas por valores sin esperar motivación previa, con registro diario de agrado y maestría.

Reevaluación a las 12 Semanas: El BAS Total ascendió a **38/52 puntos** (+16 pts, restauración del tono dopaminérgico apetitivo: Impulso = 12/16; Recompensa = 16/20), mientras el BIS descendió a **19/28 puntos** (-7 pts). El BDI-II bajó a 9 puntos, completando exitosamente su tesis académica.

9. ALERTAS DE SEGURIDAD Y DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

ALERTA BIPOLARIDAD / HIPOMANÍA:

Un incremento súbito en BAS Impulso (Drive) y Búsqueda de Diversión junto a reducción del sueño en pacientes deprimidos puede indicar viraje maniaco farmacógeno o inicio de un episodio mixto bipolar. Evaluar con MDQ / BSDS.

CONSTRUCTO RASGO VS. ESTADO:

Las Escalas BIS/BAS miden reactividades biológicas disposicionales (temperamento). Aunque los puntajes brutos se modulan con psicoterapia exitosa, los perfiles extremos reflejan vulnerabilidades biológicas que exigen pautas de higiene vital a largo plazo.

10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS CIENTÍFICAS

1. Carver, C. S., & White, T. L. (1994). Behavioral inhibition, behavioral activation, and affective responses to impending reward and punishment: The BIS/BAS Scales. *Journal of Personality and Social Psychology*, 67(2), 319-333.
2. Gray, J. A. (1987). *The psychology of fear and stress*. Cambridge University Press.
3. Ávila, C., & Torrubia, S. (2001). The Sensitivity to Punishment and Sensitivity to Reward Questionnaire (SPSRQ) as a measure of Gray's biological basis of personality. *Personality and Individual Differences*, 31(6), 837-862.
4. Romero, E., Gómez-Fraguela, J. A., Luengo, M. A., & Villar, P. (2003). Las escalas BIS/BAS de Carver y White: Propiedades psicométricas en muestras españolas. *Revista de Psicología General y Aplicada*, 56(4), 485-498.